HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Признаки воспалённого пищеварения

и почему они возникают

О чём этот урок

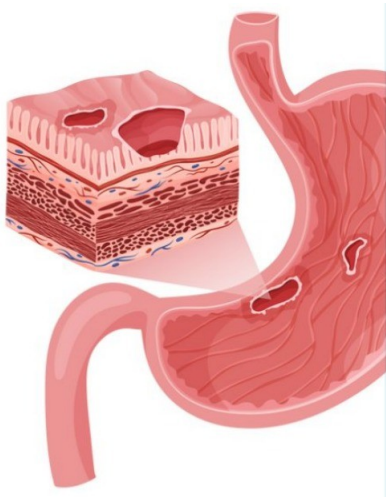
Если где-то что-то болит — за этим всегда стоит конкретный процесс. В уроке разбираем две вещи: **почему формируются воспалительные заболевания органов ЖКТ** и **что означают наши жалобы** — от пищевода и дальше по ходу движения пищи.

Воспалительный тип пищеварения — состояние, при котором есть хроническое воспаление:

- слизистой оболочки желудка, тонкой или толстой кишки;
- стенок жёлчного пузыря;
- паренхимы поджелудочной железы.

1. Причины воспалительных заболеваний органов ЖКТ

На слайдах причины собраны в список из 12 пунктов. Разберём каждый — что за ним стоит и как он запускает воспаление.



Повреждения слизистой желудка — эрозии и язвенные дефекты

1.1. Ослабление защитных факторов слизистой ЖКТ

Защитные факторы — вещества и механизмы, которые обеспечивают целостность и сохранность слизистой оболочки всех отделов ЖКТ. Они предотвращают повреждение от агрессивных сред: соляной кислоты, пищеварительных ферментов, микробов и их токсинов.

Основные защитные факторы:

- **Слизистый (муциновый) слой.** Вырабатывается клетками слизистой и создаёт физический барьер между эпителием и агрессивной средой.
- **Бикарбонаты.** Выделяются клетками желудка и поджелудочной железы и нейтрализуют кислоту у поверхности слизистой, снижая агрессивность воздействия.
- **Клеточная регенерация.** Эпителиальные клетки быстро обновляются: повреждённые клетки заменяются новыми.

- **Хорошее кровоснабжение.** Доставляет кислород и питательные вещества — а значит, обеспечивает быстрое обновление клеток.
- **Гормональные и иммунные факторы.**

> **Почему защита ослабевает.** Когда нарушается равновесие организма (гомеостаз), меняется и состояние слизистых. Ослабление защитных факторов связано с изменениями в работе нервной и гормональной систем из-за питания и образа жизни:
>
> - нарушение сна;
> - хаос в питании;
> - ненормированный рабочий график;
> - малое количество белка в питании и его плохое усвоение.

1.2. Острый и хронический стресс

Один из ключевых факторов, снижающих защитные механизмы слизистых. Есть заболевания ЖКТ, формирование которых напрямую связано со стрессом. Подробно эта тема разобрана в отдельном уроке о влиянии нервной системы на работу ЖКТ — обязательно посмотрите его.

1.3. Генетика

У некоторых людей есть врождённая склонность к ослабленному иммунитету, нарушенному синтезу слизи и бикарбонатов, изменениям моторики ЖКТ. В итоге формируется повышенная восприимчивость к воспалительным заболеваниям.

1.4. Отравления и инфекции

Helicobacter pylori, сальмонелла и другие бактериальные штаммы, вирусные инфекции, простейшие и т. д. Микроорганизмы повреждают эпителий, нарушают микробиом и активизируют иммунную систему.

1.5. Длительный приём лекарственных препаратов

Важен сам факт длительного приёма — бесконтрольного или вынужденного, по назначению врача.

Препараты	Как влияют на ЖКТ
НПВС	Угнетают синтез простагландинов → снижается защита слизистой. Существует даже язва желудка, ассоциированная с приёмом НПВС.
Глюкокортикостероиды	Подавляют иммунитет → снижается скорость заживления слизистых.
Антибиотики	Нарушают микрофлору → формируется дисбиоз.

Препараты	Как влияют на ЖКТ
Препараты железа, калия	Едкие, могут повредить слизистую. У некоторых людей именно с их приёма стартует, например, воспалительное заболевание кишечника.
Цитостатики	Указаны на слайде в списке препаратов, длительный приём которых может стать причиной воспаления.

1.6. Нарушение микробиома кишечника

Полезные бактерии защищают слизистую и модулируют иммунитет. Дисбиоз может стать фактором развития воспалительных заболеваний кишечника, синдрома раздражённого кишечника и т. д.

1.7. Нарушения моторики ЖКТ: дискинезия, рефлюкс

- **Заброс содержимого желудка в пищевод** раздражает и повреждает пищевод, создавая условия для воспаления.
- **Заброс жёлчи в желудок** раздражает слизистую желудка и тоже создаёт условия для воспаления.

1.8. Удаление жёлчного пузыря

После удаления жёлчного пузыря жёлчные кислоты больше не накапливаются в нём. Иногда они хаотично выбрасываются в кишечник и раздражают его — это может стать фактором развития воспаления.

1.9. Вторичные воспаления

Воспалительные заболевания ЖКТ могут развиваться как следствие других заболеваний: сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, аутоиммунных болезней, сахарного диабета.

Пример: аутоиммунный гастрит, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона — аутоиммунные заболевания, которые нередко развиваются после того, как у человека обнаружен **аутоиммунный тиреоидит**. Если есть одно аутоиммунное заболевание, с довольно высокой вероятностью может присоединиться и другое. Аутоиммунный гастрит и АИТ — «сладкая парочка» в плохом смысле слова.

1.10. Курение

Известный фактор формирования гастрита и язвы желудка. Механизм простой: никотин снижает кровоток и ослабляет сфинктеры. В результате повышается риск язв, ГЭРБ, гастрита.

1.11. Триггеры в питании

Переедание, избыток жареной и жирной пищи, кислых продуктов, алкоголя, кофе, газированных напитков. Эти продукты и напитки обладают **повышенным раздражающим действием** на рецепторы органов ЖКТ: может усилиться моторика и выработка пищеварительных соков. Это может стать «последней соломинкой», которая запустит воспаление.

1.12. Конституционный тип с преобладанием доши Желчь / Питта

Пункт для тех, кто интересуется восточной медициной: воспалительные заболевания ЖКТ часто возникают у людей с преобладанием доши Желчи (Питты).

2. Пища — триггер, а не самостоятельная причина

Для старта воспаления должна совпасть совокупность факторов. Классический пример — как возникает панкреатит.

Человек А	**Человек Б (сосед за столом)**
✔️ питается кое-как, пропускает приёмы пищи ✔️ много работает или учится, маленькие дети, много забот ✔️ постоянно в стрессе, спит «вполглаза» ✔️ возможно, принимает какие-то лекарства Защитные факторы слизистых снижены — он сам об этом не знает. Новогодний стол: жирное, жареное, острое, много алкоголя. **→ приступ панкреатита и больница**	✔️ стрессоустойчив ✔️ нормально спит ✔️ питается регулярно Ест всё то же самое. **→ нормально переварил, никакого панкреатита**

Вывод: пища — это спусковой крючок начала проблемы или рецидива, но не самостоятельная причина. При уже имеющемся хроническом воспалении неподходящая еда может спровоцировать приступ.

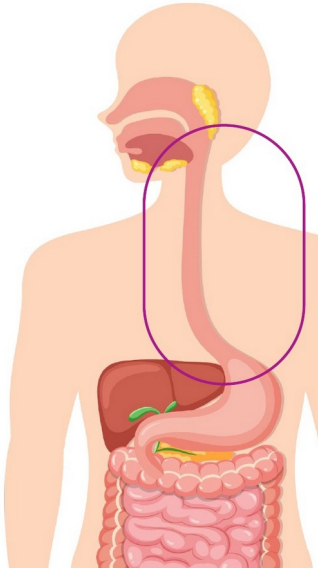
Чтобы сформировалось воспалительное заболевание — гастрит, панкреатит или воспалительное заболевание кишечника, — должно совпасть несколько факторов: **что-то в генетике, что-то в образе жизни, что-то в питании как триггер, ослабление защитных факторов, возможно — приём лекарств**. Всё это складывается в комбинацию, с которой стартует воспаление.

> **Упражнение.** Подумайте, что в вашем случае могло сформировать воспалительный тип пищеварения. Пройдитесь по 12 причинам и отметьте свои. Поделитесь в комментариях к уроку.

3. Что означают ваши жалобы

Жалоб при воспалённом пищеварении много. Они могут возникать нерегулярно, изредка — но каждая из них знаковая. Идём сверху вниз, по ходу движения пищи по ЖКТ.

3.1. Пищевод: изжога, жжение



Пищевод — зона изжоги и жжения

Начинаться всё может как **гиперчувствительный пищевод** и **функциональная изжога** — реакция нервной системы на нормальные раздражители и нормальные рефлюксы. Со временем частые забросы повреждают слизистую.

ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) — состояние, при котором снижается тонус нижнего пищеводного сфинктера (между пищеводом и желудком), и содержимое желудка забрасывается в пищевод. Если слизистая пищевода повреждена и воспалена, возникают изжога, жжение, боли.

Тип пищеварения	На что изжога	Почему
Воспалённое	**кислое, жгучее, горькое**	Продукты этих вкусов раздражают слизистую желудка и способствуют рефлюксу
Воспалённое + вялое	**сладкое, жирное, мучное, крахмалистое**	Эти продукты тормозят эвакуацию пищи из желудка — повышается шанс рефлюкса

У ГЭРБ целая совокупность причин — ему посвящён отдельный урок курса.

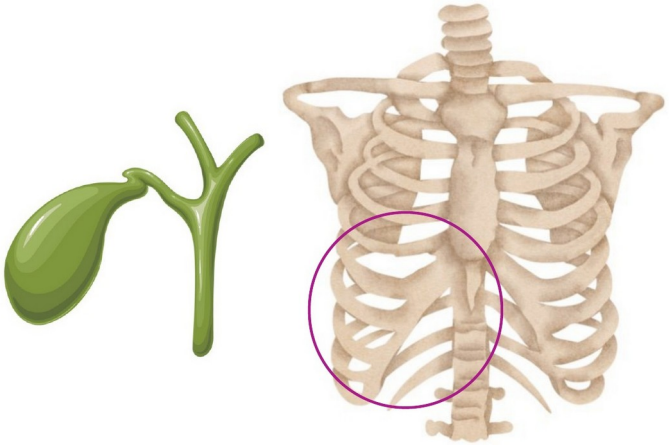
3.2. Желудок

Область желудка на теле — от **мечевидного отростка** (там, где заканчиваются рёбра) до **пупка**.

Жалоба	Что означает	Почему так
Острые боли натощак; жжение и боли через 1–1,5 ч после еды; боли на алкоголь, кислую, горькую пищу и напитки	Повреждение слизистой желудка: поверхностный гастрит, эрозивный гастрит, язва желудка (разные степени повреждения)	Через 1–1,5 ч основной объём пищи уходит в 12-перстную кишку, а кислота продолжает выделяться и контактирует с воспалёнными стенками. Алкоголь, кислое и горькое усиливают секрецию кислоты
Тяжесть после еды, медленное переваривание	Замедленная эвакуация пищи из желудка из-за воспаления слизистой и нарушения моторики	Признак больше вялого типа, но бывает и на фоне воспалённого: хроническое воспаление нарушает моторику, пища долго стоит в желудке
Отрыжка	Несмыкание («зияние») нижнего пищеводного сфинктера, ГЭРБ, замедленная эвакуация пищи из желудка	—
Чувствительность к температуре пищи (неприятно глотать холодное или горячее)	Гиперсенситивный пищевод, ослабление защитных факторов слизистой ЖКТ	—

Важно: эти жалобы — характерные признаки воспалённого пищеварения, даже если возникают изредка.

3.3. Жёлчный пузырь и жёлчевыводящие протоки



Жёлчный пузырь и зона правого подреберья

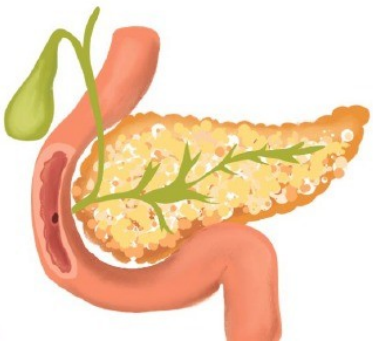
Расположены в **правом подреберье** — чуть ниже, чем отмечено кружком на слайде: рёбра закрывают печень, а всё, что ниже рёбер справа, — зона жёлчного пузыря и жёлчевыводящих путей.

Жалоба: колющие боли в правом боку, особенно после жирной и жареной пищи. Не просто дискомфорт или «тянет», а острые, пронзительные, «кинжальные» боли; могут отдавать в правую ключицу, под правую лопатку.

Что означает: воспаление или спазм жёлчного пузыря и протоков — хронический холецистит, дискинезия жёлчевыводящих путей, жёлчные камни.

Чем активнее и чаще боли, тем ярче протекает воспалительный процесс. **Если ещё не обследовались — сделайте УЗИ** и посмотрите, что происходит с жёлчным.

3.4. Поджелудочная железа

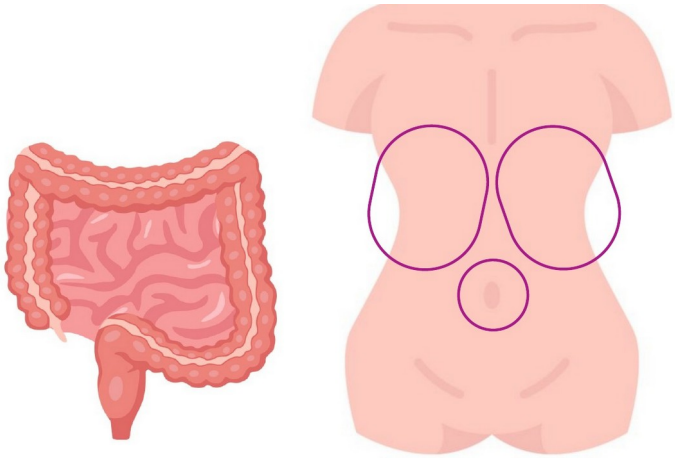


Поджелудочная железа

Для **хронического панкреатита** характерны боли **по центру живота и в левом подреберье**, которые отдают в спину, — **опоясывающие**.

Уточнение: на слайде урока по ошибке отмечено правое подреберье. Правильно — левое подреберье (об этом сказано в видео).

3.5. Тонкая кишка



Кишечник и зоны болей в животе

Жалоба: боли или жжение в животе через 1–2 часа после еды — по центру живота, справа или слева от пупка, выше или ниже. Это зона тонкой кишки.

Что означает: воспаление в тонкой кишке — дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки, энтерит, колит, болезнь Крона (иммунный процесс).

Почему в это время: примерно через час после еды пища начинает спускаться в двенадцатиперстную кишку и продвигается дальше. Когда она доходит до места воспаления, начинаются боли.

3.6. Вздутие и реакция на клетчатку

Жалоба	Что может стоять за ней
Вздутие и боли на ферментированную пищу и пробиотики: квашеная капуста, комбуча, квас, кисломолочные продукты, даже качественные пробиотики и БАДы. Живот «надувается как шарик» даже от небольшого количества	**СИБР** — синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке. Симптомы начинаются, когда бактерии перерабатывают эти продукты
Боли в животе и газообразование от клетчатки: много сырых фруктов и овощей, салаты, капустные, грубая шкурка овощей, фруктов, ягод	**СРК** — синдром раздражённого кишечника. Признак смешанный с чувствительным типом, не строго воспалительный. Может развиться «до кучи»: воспалённая слизистая даёт висцеральную гиперчувствительность — гиперреакцию на клетчатку

3.7. Диарея, несформированный стул, слизь в стуле

Маркер нарушения пищеварения в тонкой и толстой кишке. За ним может стоять целая группа причин:

- **воспалительные заболевания кишечника** — из-за воспаления плохо выделяются ферменты тонкой кишки, пища плохо переваривается;
- **недостаток ферментов тонкой кишки;**
- **гипермоторный жёлчный пузырь** — тогда это вопрос к предыдущей «станции» пищеварения;
- **СИБР;**
- **СРК.**

Чтобы понять, что скрывается за диареей, смотрят на признаки в других отделах ЖКТ и сдают анализы.

> **А запоры?** На слайдах их нет, хотя они встречаются при воспалительном типе — особенно в сочетании с чувствительным или вялым. Причин много: недостаток жидкости и клетчатки, нарушение нервной регуляции перистальтики (СРК), нарушение микробиома. Запорам посвящён отдельный урок курса.

3.8. Ещё несколько признаков

Жалоба	Что означает
Ночные боли в животе (примерно 01:00–03:00)	Хроническое воспаление в ЖКТ: хронический панкреатит, гастриты, язвенная болезнь. Если вы не обследованы по ЖКТ — начните обследование
Улучшение состояния от обволакивающей пищи	Обволакивающие субстанции снижают контакт слизистой с кислотой и ферментами — поэтому становится легче
Тошнота на жирную / белковую пищу	Плохое переваривание жиров при панкреатите или дискинезии жёлчевыводящих путей; плохое переваривание белков из-за нарушения работы желудка (например, хронического воспаления); медленная эвакуация пищи из желудка. Признак бывает и при вялом, и при смешанном типе (воспалённое + вялое)

4. Шпаргалка: жалоба → что за ней стоит

Отдел	Жалоба	Возможная причина
Пищевод	Изжога, жжение	Гиперчувствительный пищевод, функциональная изжога, ГЭРБ

Отдел	Жалоба	Возможная причина
Желудок	Боли натощак, через 1–1,5 ч после еды, на алкоголь/кислое/горькое	Гастрит (поверхностный, эрозивный), язва желудка
Желудок	Тяжесть после еды	Замедленная эвакуация пищи, нарушение моторики
Желудок	Отрыжка	Несмыкание НПС, ГЭРБ, замедленная эвакуация
Пищевод / ЖКТ	Неприятно глотать холодное/горячее	Гиперсенситивный пищевод, ослабление защитных факторов
Правое подреберье	Колющие боли после жирного, жареного	Холецистит, дискинезия ЖВП, жёлчные камни
Центр живота, левое подреберье	Опоясывающие боли, отдают в спину	Панкреатит
Тонкая кишка	Боли/жжение через 1–2 ч после еды	Дуоденит, язва ДПК, энтерит, колит, болезнь Крона
Кишечник	Вздутие на ферментированное и пробиотики	СИБР
Кишечник	Боли и газы от клетчатки	СРК
Кишечник	Диарея, несформированный стул, слизь	ВЗК, нехватка ферментов, гипермоторный ЖП, СИБР, СРК
ЖКТ	Ночные боли (01:00–03:00)	Хронический панкреатит, гастриты, язвенная болезнь
ЖКТ	Тошнота на жирное/белковое	Плохое переваривание жиров/белков, медленная эвакуация

Воспаление стартует, когда складывается комбинация факторов. Пища — лишь триггер. А каждая жалоба указывает на конкретный отдел ЖКТ и конкретный процесс.

В следующих уроках разбираем, что со всем этим делать.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое воспалительный тип пищеварения? Воспаление каких органов и структур к нему относится?
2. Какие защитные факторы слизистой ЖКТ вы знаете? Какую роль играет каждый из них?
3. Какие факторы образа жизни и питания ослабляют защиту слизистых?
4. Каким образом НПВС, глюкокортикостероиды, антибиотики и препараты железа/калия могут запустить воспаление в ЖКТ?
5. Почему удаление жёлчного пузыря может стать фактором воспаления в кишечнике?
6. Как курение влияет на риск гастрита, язвы и ГЭРБ?
7. Почему пищу называют триггером, а не самостоятельной причиной воспаления? Поясните на примере панкреатита.
8. Какая изжога характерна для воспалённого типа пищеварения, а какая — для сочетания воспалённого и вялого? Почему?
9. Почему при гастрите и язве желудка боль возникает через 1–1,5 часа после еды?
10. Где на теле находится зона жёлчного пузыря и какие боли указывают на его воспаление или спазм?
11. Какие боли характерны для хронического панкреатита? Какое подреберье — правое или левое?
12. Почему боли при воспалении тонкой кишки возникают через 1–2 часа после еды?
13. Реакция на какие продукты указывает на СИБР, а на какие — на СРК?
14. Какие причины могут скрываться за диареей и несформированным стулом?
15. О чём говорят ночные боли в животе с 01:00 до 03:00?
16. Почему при воспалённом пищеварении становится легче от обволакивающей пищи?

> **Задание для себя.** Выпишите свои жалобы, сопоставьте их с отделами ЖКТ по шпаргалке и отметьте, какие из 12 причин могли сформировать воспалительный тип пищеварения в вашем случае.